

# تقرير مراجعة عربية للصور الطبية

مقارنة أرشيف الصور الطبية مع التقرير المرفق

المريض: العمر: 38 سنة و 11 شهرا

تاريخ الدراسة الظاهر في الملفات: 02092026

## الخلاصة التنفيذية

مع إعادة تشكل خفيفة في رأس وعنق الفخذ. هذا مظهر تنكسي مزمن وليس آفة عظمية مدمرة أو دليلا بحد ذاته على انتشار ورمي. الأيسر. تظهر في الصور خسارة غير متناظرة في المسافة المفصالية، وتصلب عظمي، وكيسات تحت غضروفية متعددة، ونابتات عظمية أهم نتيجة غير مذكورة في التقرير هي وجود اعتلال أو خشونة مزمنة متوسطة إلى شديدة في مفصل الورك. السلسلة 2 من الصورة 84 إلى 92 والسلسلة 3 من الصورة 34 إلى 41، وكذلك السلسلتين 11 و 12 والصور الرقيقة من السلسلة 14. النتيجة الخاصة بالورك الأيسر مؤكدة بدرجة عالية، وأفضل ما تظهر في لم أجد كتلة مثناة ثالثة مقنعة أو ثقيلة واضحة إضافية في الكبد أو الرئتين أو العقد اللمفاوية. يصف الكتلتين المثنيتين بشكل متوافق إجمالاً مع الصور، لكن التصوير المقطعي لا يستطیع وحده تحديد غزو عضلة المثناة مجهرياً. التقرير

## مقارنة تفصيلية

| نتيجة مراجعة الصور مقارنة بالتقرير                                                                                                                                                                                                                                                                    | البند            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| اليمنى نحو من 12 إلى 14 مم طولاً ومن 7 إلى 9 مم عرضاً بارتباط أوسع. لا توجد كتلة ثالثة مقنعة. اليسرى نحو من 17 إلى 19 مم طولاً ومن 9 إلى 11 مم عرضاً بارتباط ضيق، وكتلة جهة المريض المثناة قرب منطقتي الوصل الحالبى المثنى. القياسات متوافقة تقريباً مع التقرير: كتلة جهة المريض كتلتان وعائيتان داخل | المثناة          |
| كلوي أو حالبى، ولا عقد لمفاوية متضخمة. لكن غياب الامتداد خارج المثناة لا يثبت عدم غزو العضلة. لا يوجد امتداد واضح إلى الدهن حول المثناة أو الأعضاء المجاورة، ولا توسع                                                                                                                                 | الانتشار الموضعي |
| الجزء الكامل بعدم التعزز، وكونها صغيرة جداً يجعل التصوير بالرنين المغناطيسي مناسباً عند الحاجة. وأخرى نحو من 5 إلى 7 مم. لا توجد نقيلة كبدية مؤكدة. مرحلة 35 ثانية لا تشمل الكبد؛ لذلك لا يمكن توجد البؤر الصغيرة ناقصة الكثافة المذكورة في التقرير، وأكبرها نحو 8 مم                                 | الكبد            |
| سم للكلية اليمنى. قد يمثل ذلك ضموراً أو تندباً مزمنياً، مع بقاء الإطار طبيعياً وعدم وجود انسداد. الكلية اليسرى صغيرة ومفصصة مع ترقق قشري؛ حجمها نحو 9 سم مقابل 11.8                                                                                                                                   | الكلية اليسرى    |
| تحت غضروفية، نابتات عظمية وإعادة تشكل. هذه هي الملاحظة المهمة التي لم تذكر في التقرير. اعتلال تنكسي مزمن متوسط إلى شديد مع تضيق مفصلي، تصلب، كيسات                                                                                                                                                    | الورك الأيسر     |

## ملاحظات تقنية مهمة

الصوتية أو الدوبلر ضمن ملف ؛ لذلك لا يمكن التحقق من عبارة التقرير عن الأوعية المغذية والدوبلر من هذا الأرشيف وحده. يحتوي على 2297 صورة للتصوير المقطعي، إضافة إلى تقرير جرعة وملف تقرير مضمن. لا توجد صور للموجات فوق الأرشيف

البطن، ومرحلة وريدية للبطن والحوض، ومرحلة متأخرة بعد 15 دقيقة. التقرير لا يوضح هذه التفاصيل في قسم تقنية منفصل. الفحص متعدد المراحل: مرحلة قبل التباين، ومرحلة مبكرة للحوض وأسفل

في كل المقاطع؛ لا يوجد انسداد واضح، لكن لا يمكن استبعاد آفة مخاطية حالبية صغيرة بصورة كاملة من هذه الدراسة وحدها. الأجزاء الحالبية ليست ممثلة بالتباين بشكل مستمر

البروستاتا والحوصلتان المنويتان وقواعد الرئتين والأمعاء تبدو دون آفة كبيرة واضحة، لكنها غير موصوفة تفصيلا في التقرير.

## ما الذي لا يستطيع التصوير المقطعي حسمه؟

لا يمكن تأكيد نوع كتلة المثانة أو درجتها أو عمق غزوها دون تنظير واستئصال أو خزعة عبر الإحليل وفحص نسيجي.  
لا يمكن للتصوير المقطعي استبعاد غزو مجهري للعضلة أو نقائل مجهرية في العقد اللمفاوية.  
سبب صغر الكلية اليسرى لا يمكن التفريق فيه بثقة بين نقص خلقي في الحجم وتندب أو ضمور مزمن اعتمادا على هذه الصور فقط.  
اعتلال الورك الأيسر لا يمكن تحديده بدقة من التصوير المقطعي وحده؛ قد يكون خشونة مزمنة أو أثرا قديما لمرض أو إصابة سابقة.  
سبب

## التوصيات العملية

طلب إضافة رسمية من اختصاصي الأشعة تتضمن اعتلال الورك الأيسر وتوضح أن مرحلة 35 لا تشمل الكبد.  
البولية لإجراء تنظير المثانة واستئصال الورم عبر الإحليل مع التأكد من وجود عضلة الديتروسور في العينة لتحديد مرحلة الورم.  
متابعة اختصاصي المسالك  
تصوير بالرنين المغناطيسي للكبد مع التباين أو متابعة تصويرية حسب قرار الطبيب، خصوصا إذا أكد الفحص النسيجي وجود ورم.  
إجراء  
الورك الأيسر، ينصح بصورة أشعة مخصصة للحوض أو الورك وتقييم عظام؛ ويبحث عند الاشتباه بنخر عظمي أو سبب آخر.  
إذا كان هناك ألم في

## المراجع والحدود

للمسالك تؤكد أن الكتلة المرئية بالتصوير تحتاج إلى وفحص نسيجي، وأن لا يميز بدقة بين بعض درجات الغزو العضلي.  
تمت مراجعة السلاسل المحورية الرقيقة، وإعادة البناء الإكليلية والسهمية، ومراحل التباين والتأخير. إرشادات الجمعية الأوروبية  
هذه مراجعة ثانية للصور والوثائق وليست تشخيصا نهائيا ولا بديلا عن تقرير اختصاصي الأشعة أو نتيجة الخزعة.

مرجع إرشادات المسالك الأوروبية: تقييم وتشخيص أورام المثانة